ACTA No 1 -2026
APLICACIÓN INSTRUMENTO ISABEL
Instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica en Línea

FECHA REUNIÓN	10 de febrero 2026		
LUGAR:	ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ		
HORA INICIO:	8:00 a.m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	01:00 p.m.
RESPONSABLES:	Jessica Paola Gutiérrez C. Médico Nelcy Vianney Torres Vianchá Enfermera Profesionales especializados de apoyo, línea maternidad, programa de Salud Sexual y Reproductiva		
ASISTENTES:	Sharon Katherine Acuña Líder de ginecología Laura Camila Martínez Subgerente (e) Mabel Rocío Gómez Mantilla Líder SMP Luisa Fernanda Bautista Apoyo a coordinación Melby Hernadez Líder de calidad Se adjunta lista de asistentes. Diligenciar formato (E-DO-TH-F-003)		
OBJETIVO:	• Aplicar instrumento de evaluación de la respuesta institucional frente a la emergencia obstétrica ISABEL • Reforzar en la institución estrategias para avanzar en la atención de gestantes y sus recién nacidos, a partir de la atención de urgencias. • Analizar y evaluar las condiciones de prestación del servicio en el componente de Maternidad Segura en la Red de Prestación de Servicios de Salud en el departamento de Boyacá con enfoque de garantía de la calidad en la atención de las mujeres antes, durante y post evento obstétrico.		

ORDEN DE DÍA

1. Presentación de los profesionales de la ESE y la Secretaría.
2. Indicar objetivos de la visita.
3. Realizar asistencia técnica y seguimiento de compromisos, en paquetes instruccionales – prácticas claves que salvan vidas en la emergencia obstétrica indicados desde el instrumento ISABEL y PARE MM.
4. Retroalimentación de los hallazgos y compromisos.
5. Cierre de la visita.

DESARROLLO

- Se da inicio a la visita con la socialización de los objetivos y dinámica que se llevará a cabo, (asistencia técnica y verificación de procesos de atención materno perinatal), por parte de los funcionarios de la Secretaría de Salud de Boyacá, ante los funcionarios asistentes de la IPS, cuyo propósito es realizar un

seguimiento y revisión general de la calidad de la atención materno perinatal, en el marco del PAREM (Plan de aceleración para la reducción de la muerte materna) acompañada de un proceso de aclaración de dudas, inquietudes y asesoramiento para el mejoramiento y mantenimiento en la implementación de la ruta materno perinatal (con enfoque en atención a emergencias obstétricas), se explica a los asistentes que los compromisos pactados en esta visita, serán objeto de seguimiento posterior por parte del equipo delegado de la Dirección Técnica de prestación de servicios de la Secretaría de salud de Boyacá, en el marco del cumplimiento de los lineamientos impartidos en las circulares 005 de 2012, 016 del 2017 y 047 de 2022 y circulares departamentales.

- Aplicación Instrumento Evaluación de la Respuesta Institucional frente a la Emergencia Obstétrica (ISABEL) en servicio de atención de gestantes, con la aplicación del instrumento, se espera en términos generales una cualificación de las competencias de la institución con servicios de obstetricia, para la prevención, detección temprana, tratamiento precoz y remisión en condiciones que salvan vidas.

- El instrumento aborda de manera comprehensiva los ítems críticos, en la secuencia lógica del proceso asistencial para la atención de una gestante en una Institución de salud, ingresando desde Urgencias, admisiones, sala de partos, Cirugía y demás servicios derivados. Además, el instrumento integra lo contenidos y estructura de los paquetes de intervención o "bundles", propuestos por OMS, FIGO y la Alianza por la Innovación en Salud Materna. De esta manera se evalúan las siguientes líneas:

  PREPARACIÓN INSTITUCIONAL.
  PREVENCION Y RECONOCIMIENTO DE COMPLICACIONES.
  RESPUESTA A LA EMERGENCIA OBSTERICA.
  REMISION EN CONDICIONES QUE SALVAN VIDAS.
  REPORTE Y APRENDIZAJE INSTITUCIONAL
  RESPETO Y HUMANIZACIÓN.

- Se aplica cada ítem para el final dar un puntaje especifico, posterior se realiza retroalimentación en cada ítem que requiere intervención inmediata con su respectivo compromiso. Se realiza revisión de Historias Clínicas, de casos de MME con 3 o más criterios, con la aplicación de Instrumento de Evaluación de la aplicación y operativización de :
  - Triage Obstétrico
  - Escala de Alerta Temprana Emergencia Obstétrica
  - Mecanismos de comunicación estrategia SBAR.
  - Instrumento de Clasificación de Riesgo Tromboembólico
  - Escala de Clasificación de Riesgo Biopsicosocial
  - Diagrama de Flujo de la Atención de la Emergencia Obstétrica.
  - Implementación de Listas de chequeo y paquetes de intervención en Emergencia Obstétrica.

Dentro de los casos de MME reportados al Sivigila procedentes o residentes de Moniquirá a la semana 4 se encuentran:

Semana E	edad	Evento MME	Total, Criterios	UPGD	Documento
2	26	Preeclampsia Severa	1	HRM ESE	1005363436
3	21	Hemorragia obstétrica	1	HRM ESE	1055126194

En el desarrollo de la visita se encuentra:

- Cuentan con triage obstétrico sistematizado, aplicado por profesional en enfermería, el tiempo de atención es mínimo, ya que si se clasifica como un triage 1 pasa directamente a reanimación para valoración inmediata por urgencias y activación de ERR para llegada de ginecólogo. En casos de triage 2 y 3 son valorados directamente por ginecólogo en espacio de admisiones ginecología.

- Desde triage implementan también escala de qSOFA a todas las pacientes con sospecha de cuadro infeccioso. (Puede servir como referencia a las demás IPS).

- Muestran continuación en cuanto a capacitación al personal en Talleres basados en simulación y seguimiento de adherencia a la estrategia: Para este año, cada mes trabajan sobre una causa de MME, todo el mes se realiza capacitación incluyendo los servicios de cirugía y UCI, para que haya una correcta articulación de la información ante una emergencia obstétrica.

- Cuentan con personal tanto ginecólogos como hospitalarios, certificados en tele consulta para el tele apoyo (Certificación con la Universidad Nacional, Hospital universitario).

- Dentro de los programas de capacitación realizados al área de influencia de la ESE, los primeros niveles no asisten a las capacitaciones convocadas, piden apoyo a la Secretaría para que desde allí se requiera a los municipios para el compromiso de participación, las ESE de primer nivel no utilizan el tele apoyo en los casos de remisión, no todas estabilizan adecuadamente para remitir o no envían con la documentación requerida como lo es la hoja de alerta temprana. Municipios del área de influencia que remiten: Toguí, Chitaraque, Santana, San José de Pare, Santa Sofía y los municipios que pertenecen a otra provincia pero que también suelen enviar gestantes Gachantivá, Arcabuco, y Villa de Leyva.

- Manejan mecanismos de comunicación SBAR, sin embargo, denota interés en mantener comunicación precisa al momento de la emergencia, por lo que han creado la estrategia “IDEAS” la cual se diligencia en físico y es una ayuda rápida en cuanto a la emergencia.
  I: Identificación de la paciente
  D: Diagnóstico
  E: Estado clínico actual: SV, Estado de la paciente, Triage, Meows , qSofa
  A: Actividades Realizadas
  S: Solicitudes pendientes

- Han fortalecido el procedimiento de equipo de respuesta rápida, el cual se activa mediante timbre y WhatsApp, donde se convoca a todos los implicados en caso dado, como pediatría - UCI - anestesiología - laboratorio – perinatología – salas de cirugía, referencia, entre otros.

- Para este año cuentan con perinatologo 4 días a la semana, generan oportunidad en citas por perinatología a gestantes de alto riesgo, mediante estrategia SOS MATERNAS en conjunto con líder de ginecología y profesional encargado de agendamiento exclusivo para ginecoobstetricia.

- Miden su adherencia a guías y protocolos mediante indicadores, los cuales se revisan, con tasas bajas en mortalidad materna por emergencias obstétricas. Además mantienen bajas tasas anuales de cesárea.

- Promedio de atención de partos mensual es de 62, de estos aproximadamente el 25% son por cesárea, lo cual resalta la adherencia en cuanto al indicador recomendado por OPS de no superar el 30%.

- En el momento se encuentra en farmacia 144 bolsas para cuantificación de sangrado disponibles.

- Se habilitó un nuevo quirófano (Mayor disponibilidad para atención de casos, entre estos MME).

- Se evidencia que están trabajando en elaboración de videos educativos para el personal, para la atención de la Emergencia Obstétrica, paso a paso, de manera didáctica.

- En los consultorios de consulta externa, ya se cuenta con los Kit para tomas de pruebas rápidas (Están gestionando Casetes que leen las tres muestras).

- Se entrega Infografía de EMOTIVE, para que sea socializada y publicada, como insumo de apoyo en MME.

- En la revisión de HC, mediante aplicación de formato, cumplen con los tiempos y con lo indicado según listas de chequeo, diligenciada con medicamentos y manejo aplicado según sea el caso presentado.

- Se garantiza egreso seguro mediante la garantía de entrega de medicamentos y asignación de citas, por parte de la EAPB antes del alta.

- Durante recorrido se establece comunicación directa con gestante que se encontraba en trabajo de parto, La usuaria refiere contar con información previa, proporcionada por la institución, respecto a sus derechos en el marco de la atención materna y al modelo de parto humanizado. Asimismo, manifiesta conocimiento sobre las alternativas de analgesia obstétrica disponibles y su derecho a la toma de decisiones informada. Se evidencia el respeto a su autonomía, garantizando el acompañamiento permanente durante el proceso y el derecho a la libre deambulación, en concordancia con las buenas prácticas clínicas y los lineamientos de calidad en la atención en salud materno-perinatal.

  - Se entrega ENLACE CAJA DE HERRAMIENTAS SSR: https://boyacagob-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fsalud%5Fsexualyreproductiva%5Fboyaca%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEQUIPO%20SSR%202025%2FCAJA%20DE%20HERRAMIENTAS%20DSDSR%202025%2FSALUD%20MATERNA&ga=1 con información específica de la línea de maternidad segura (PARE MM, Emergencias obstétricas, circulares y memorandos del departamento, redes sociales y comunitarias, capacitaciones realizadas en el marco del PARE MM)

  - Se recuerda la asistencia a las unidades de seguimiento territoriales todos los miércoles a las 2:00pm, en el siguiente enlace de conexión

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM3NjBlNWUtOTM1Ni00NmZiLWFhOTktYzgzNTI3OTkzNTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22620104e2-1390-43c5-ba45-85d1883cc488%22%2c%22Oid%22%3a%22acb15f65-18fc-4adc-991f-ac3ff748607b%22%7d

Se entrega puntaje final obtenido luego de la aplicación del instrumento **ISABEL:**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100,00%

COMPROMISOS						
No	**DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO**	**META**	**PLAZO**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	**RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO**
1	Incorporar en descripción de atención de la Emergencia Obstétrica el uso de la lista de chequeo.	Descripción en la HC	Inmediato	Personal que atiende las gestantes	05 de mayo de 2025	Equipo SSR Línea maternidad
2	En los registros de enfermería, incluido recibo y entrega de turno, describir el puntaje de la hoja de alerta temprana, con la acción de enfermería a seguir, según puntaje.	Registros de enfermería con descripción de la escala MEOWS obstétrico	Inmediato	Enfermería	05 de mayo de 2025	Equipo SSR Línea maternidad
3	Incorporar Methergin en el kit de emergencia obstétrica, una vez haya disponibilidad a nivel nacional	Disponibilidad del medicamento en farmacia y en los kit de EO	Inmediato	Gerencia, subgerencia científica.	Cuando haya disponibilidad a nivel nacional	Equipo SSR Línea maternidad

OBSERVACIONES

- Se destaca la adecuada organización de toda la documentación solicitada, tanto en físico como digitalizada, lo cual facilita el acceso ágil a la información, optimiza el desarrollo de la asistencia técnica y, a su vez, favorece a los profesionales de salud al momento de requerir información específica.
- Realizar inducción en cuanto a estrategia ISABEL al personal que ingresa que incluye Triage Obstétrico, Clasificación del riesgo Obstétrico. Aplicación de Listas de Chequeo, Manejo de Escalas de Alerta Temprana.
- Continuar garantizando condiciones de alta segura en Paciente Obstétrica lo cual incluye:

  - Garantía de asesoría y provisión de anticoncepción post evento obstétrico de larga duración o definitivo, de acuerdo con los criterios de elegibilidad OMS y elección de la usuaria.
  - Garantía de los medicamentos necesarios para el tratamiento ambulatorio completo (Ninguna IPS puede dar de alta a la mujer sin que se le haya hecho entrega efectiva de los antibióticos, antihipertensivos, trombo profilaxis, analgésicos, etc. necesarios para el manejo).
  - Cita agendada de control postparto entre los 3 y 5 días posteriores al alta, para la usuaria y el recién nacido: cita agendada en los primeros 7 días con Ginecología, medicina materno fetal o especialidades de acuerdo con lo requerido: en caso de que la usuaria con evento de MME en gestación.
  - Garantía de educación y comprensión de los signos de alarma para reconsultar, por parte de la usuaria y su familia.
  - En caso de que la usuaria requiera albergue u HOGAR DE PASO por residencia en municipio rural disperso la EAPB/EPS debe garantizarlo en el territorio de la IPS de seguimiento de mayor complejidad.
- Informar inconsistencias al correo salud.sexualyreproductiva@boyaca.gov.co
- Próxima Visita en 3 meses; por indicación del Ministerio de Salud, a las Instituciones del PARETO (que atienden el mayor número de partos en el departamento) se les realizará mínimo 4 visitas en el año, para seguimiento de la aplicación de la estrategia del Plan de aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna.

Elaboró: Jessica Paola Gutierrez. Nelcy Vianney Torres Vianchá
Profesionales de apoyo equipo salud sexual y reproductiva
Línea maternidad segura
Dirección de Promoción y Prevención en Salud – Secretaría de Salud de Boyacá

Anexo 1. Evidencias fotográficas





Anexo 2. Lista de asistencia

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 05/Ago/2019

TEMA: Aplicación Instrumento de Evaluación de la Respuesta Institucional frente a la Emergencia Obstétrica (ISABEL).

OBJETIVO: Realizar asistencia técnica y cualificación de las competencias de instituciones con servicios de obstetricia de baja, mediana y alta complejidad para la prevención, detección temprana, tratamiento precoz y remisión en condiciones que salvan vidas.

FECHA: 10-Febrero-2025 **HORA:** 08:00 **LUGAR:** Hospital Regional Moniquirá ESE

RESPONSABLE: Jessica Gutierrez - Nelcy Torres **PROCESO:** Gestión integral de la salud

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	Laura Camila Martinez	1054802211	HRM	Obstetra (C.S)	3125291632	———	Moniquirá	
2	Mabel Rocio Gómez M	60'370.093	HRM	Lider SMP. Adjunto	3017291271	mabelgomez@...	Moniquirá	
3	Yhenin Pulido R.	1073601644	HRM	Jefe Comunicaciones	3002947692	Luispulido@...	Moniquira	
4	Jessica Gutierrez	1018982320	USALUD	Profesional Ap.	3209022800	Jessi_1896@hotmail.com	Monguira	
5	Nelcy V. Torres	52327077	SESALUD	P. Apoyo SSR	3208007054	nevtovi@gmail.com	Moniquirá	
6	Jessa Fernanda Portilla	1057892019	HRM	A. Coordinación	3219812979	[illegible]	Moniquirá	
7	Nelly Hernandez	40028756	HRM	L-Calidad	3103390893	calidad@hrmoniquira.gov.co	Moniquirá	

Anexo 3. Formato Excel INSTRUMENTO ISABEL